



El observatorio SoledadES vincula la soledad no deseada con un mayor riesgo de problemas de salud mental, un estudio de Psicothema cifra en 51 días la espera media para la primera consulta de psicología clínica y la Xunta de Galicia amplía su red de psicología clínica en atención primaria: claves del 16 de agosto de 2026

DOMINGO 16 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

El observatorio SoledadES confirma que la soledad no deseada y los problemas de salud mental se retroalimentan y afectan a una parte significativa de la población española. Un estudio publicado en Psicothema cifra en 51 días la espera media para la primera consulta de psicología clínica en las unidades de salud mental públicas y advierte de su impacto en la continuidad del tratamiento. La Xunta de Galicia amplía su red de psicología clínica en atención primaria y prepara un nuevo plan de salud mental para el periodo 2026-2030. La OPS impulsa planes locales que incorporan la salud mental en distritos de Perú afectados por la inseguridad ciudadana. Una revisión publicada en JAMA Psychiatry encuentra evidencia todavía limitada sobre las intervenciones específicas frente al impacto del cambio climático en la salud mental, aunque las intervenciones basadas en la naturaleza muestran resultados prometedores en otros contextos.

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

El observatorio SoledadES vincula la soledad no deseada con un mayor riesgo de problemas de salud mental en España

El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES), impulsado por Fundación ONCE y Fundación AXA, ha presentado el informe Soledad no deseada y salud mental en España 2026, elaborado a partir de una encuesta representativa de la población residente en el país. El estudio concluye que la relación entre la soledad no deseada y la salud mental es estrecha y bidireccional: ambos fenómenos se influyen mutuamente y generan dinámicas de retroalimentación que dificultan la recuperación y el bienestar. Según los datos recogidos, la soledad no deseada afecta al 20,2 % de la población adulta residente en España, y los problemas de salud mental, diagnosticados o no, afectan al 24,0 %. El 58,4 % de las personas que sufren soledad presenta también problemas de salud mental, frente al 15,2 % de quienes no sienten soledad; a la inversa, la soledad es casi cinco veces más frecuente entre quienes tienen problemas de salud mental (49,1 %) que entre quienes no los tienen (11,0 %). El informe destaca que un 43,8 % de las personas que combinan soledad y problemas de salud mental ha tenido pensamientos autolesivos o suicidas, frente al 2,1 % de quienes no presentan ninguna de las dos situaciones. El estudio identifica como grupos con mayor vulnerabilidad a las personas con discapacidad o dependencia, las mujeres, las personas jóvenes, quienes viven solas, quienes atraviesan dificultades económicas y las personas LGTBI+. El 77,6 % de la población encuestada considera bastante o muy difícil reconocer un problema de salud mental ante los demás.

Fuente: Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) — Fundación ONCE y Fundación AXA

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

La Xunta de Galicia amplía su red de psicología clínica en atención primaria y anuncia un nuevo plan de salud mental para 2026-2030

El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha destacado la puesta en marcha de la Red Gallega de Psicología Clínica en Atención Primaria durante la inauguración de la III Jornada de Buenas Prácticas en Salud Mental, celebrada en Santiago de Compostela y organizada por la Xunta en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Según ha explicado, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha pasado de contar con siete a veintiocho psicólogos clínicos en el primer nivel asistencial este año, con el compromiso de alcanzar los cincuenta profesionales en 2030. El conselleiro ha señalado que esta red supone un cambio de modelo que refuerza la capacidad asistencial, facilita un acceso más temprano a la atención psicológica y consolida el trabajo interdisciplinar entre psicología clínica, medicina de familia, enfermería, psiquiatría y trabajo social. La red forma parte del nuevo Plan estratégico de salud mental que la Xunta de Galicia presentará próximamente para el período 2026-2030, centrado en el modelo comunitario e integral de atención, con la prevención, la humanización, la coordinación asistencial, la innovación y la evaluación de resultados como ejes fundamentales. Gómez Caamaño también citó como ejemplo de la dimensión creativa de la recuperación proyectos como ArtEspida, del Hospital Piñor, las iniciativas de música, teatro y producción audiovisual del Hospital Psiquiátrico de Conxo, y la radio comunitaria Filispim del hospital de día de psiquiatría de Ferrol.

Fuente: Conselleiro de Sanidade, Xunta de Galicia (Europa Press / GaliciaPress)

Noticias internacionales

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La OPS impulsa planes intersectoriales que incorporan la salud mental en distritos de Perú frente a la inseguridad ciudadana

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha informado de la puesta en marcha de planes intersectoriales de acción en las regiones de La Libertad y Arequipa, en Perú, en el marco de la Iniciativa Especial de Acción Multinacional sobre los Determinantes Sociales de la Salud, financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE). Los planes, elaborados con la metodología de Teoría de Cambio por

equipos motores distritales previamente capacitados, reúnen a autoridades locales, representantes de los gobiernos regionales de salud y otros actores estratégicos, e incluyen líneas de acción, responsabilidades institucionales y mecanismos de rendición de cuentas y sostenibilidad. El primer taller se celebró el 8 de junio en los distritos de La Esperanza y El Porvenir, en la región de La Libertad: en La Esperanza el plan prioriza la prevención y reducción de la violencia intrafamiliar, mientras que en El Porvenir se han priorizado intervenciones orientadas a mejorar la salud mental frente a los efectos de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. El segundo taller, celebrado el 11 de junio en los distritos de Yura y José Luis Bustamante y Rivero, en la región de Arequipa, abordó en Yura las bajas coberturas de vacunación y la sobrepoblación canina, y en José Luis Bustamante y Rivero el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles y los trastornos de salud mental asociados a la inseguridad. La OPS ha señalado que continuará acompañando estos procesos locales para reforzar la articulación intersectorial.

Fuente: OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud)

Publicaciones científicas recientes

Miras-Aguilar, M. del M., Ruiz-Gutiérrez, J., Martínez-Gómez, S., Pérez-GarcíaAbad, S., Ramos-Barrón, C., Pariente-Rodrigo, E., Piñán-Setién, L., Otero-Cabanillas, N., Priede, M. I., y González-Blanch, C. (2026). Tiempos de espera en psicología clínica de las unidades de salud mental públicas: predictores de asistencia a primera consulta y abandono temprano. *Psicothema*, 38(1), 13-22.

DOI: [10.70478/psicothema.2026.38.02](https://doi.org/10.70478/psicothema.2026.38.02)

Hallazgo: Un equipo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y el Servicio Cántabro de Salud, liderado por María del Mar Miras-Aguilar y César González-Blanch, realizó un estudio observacional retrospectivo con 2.765 pacientes mayores de 18 años derivados desde atención primaria a cuatro unidades de salud mental del área de Santander durante 2021, empleando regresiones logísticas y curvas ROC para analizar la influencia de los tiempos de espera en la asistencia a la primera cita y en el abandono temprano del tratamiento. El tiempo medio de espera para la primera consulta fue de 58,2 días, con una mediana de 51 días, y el 65,6 % de la muestra superó las seis

semanas que marca el estándar clínico recomendado. Entre la primera y la segunda consulta, la espera media fue de 40,9 días, con una mediana de 35 días. La asistencia a la primera cita alcanzó el 84,6 % de los pacientes, mientras que el abandono temprano se registró en el 15,8 % de quienes recibieron una segunda cita, asociado sobre todo a un mayor intervalo entre consultas, ser hombre y tener menos edad.

Implicación clínica: Los autores plantean que estos resultados sugieren la necesidad de una revisión estructural del sistema de salud mental público, con un posible refuerzo de los recursos humanos en psicología clínica y una mejora de la coordinación entre atención primaria y las unidades de salud mental, sin que ello implique una recomendación clínica individualizada sobre casos concretos.

Herramientas clínicas e instrumentos

- **Plataformas de estimulación cognitiva digital:** Programas y aplicaciones validados para uso clínico que permiten diseñar ejercicios de estimulación cognitiva personalizados y hacer seguimiento remoto de la evolución de cada paciente, útiles como complemento de la intervención neuropsicológica presencial.
- **Plataformas de telepsicología con protocolos de buenas prácticas:** Herramientas de videoconsulta que incorporan cifrado de extremo a extremo y siguen los códigos de buenas prácticas en telepsicología promovidos por los colegios oficiales, orientadas a proteger la confidencialidad de los datos de salud y a garantizar la calidad de la atención a distancia.

Prioridades del día

Visibilizar el vínculo entre soledad y malestar psicológico en la consulta

A la vista de los datos del observatorio SoledadES, puede ser útil incorporar preguntas específicas sobre soledad no deseada en la anamnesis inicial,

especialmente con pacientes que viven solos, atraviesan dificultades económicas o pertenecen a colectivos con mayor vulnerabilidad social.

Revisar los circuitos de acogida y continuidad entre primera y segunda consulta

Los hallazgos del estudio publicado en Psicothema sobre las unidades de salud mental públicas sugieren que puede ser relevante prestar especial atención al intervalo entre la primera y la segunda cita en consultas privadas y programas propios, dado que un mayor tiempo de espera se asocia a un mayor riesgo de abandono temprano del tratamiento.

Explorar el papel de las intervenciones basadas en la naturaleza como complemento terapéutico

Con la prudencia que exige una evidencia todavía mayoritariamente de baja credibilidad, puede ser oportuno valorar actividades en contacto con entornos naturales como recurso complementario para el manejo de la tensión, la fatiga o el afecto negativo, sin sustituir a las intervenciones psicológicas basadas en la evidencia.